



HÉMOPHILIE A ACQUISE AU POST PARTUM : À PROPOS D'UN CAS

A. AMIRECHE¹, A. KESSIRA¹, M. MADJEN¹, S. GUERFI¹, H. BROUK¹

¹ Service d'hémodiologie et transfusion sanguine Annaba



HÉMOBIOLOGIE
ET TRANSFUSION
SANGUINE
ANNABA



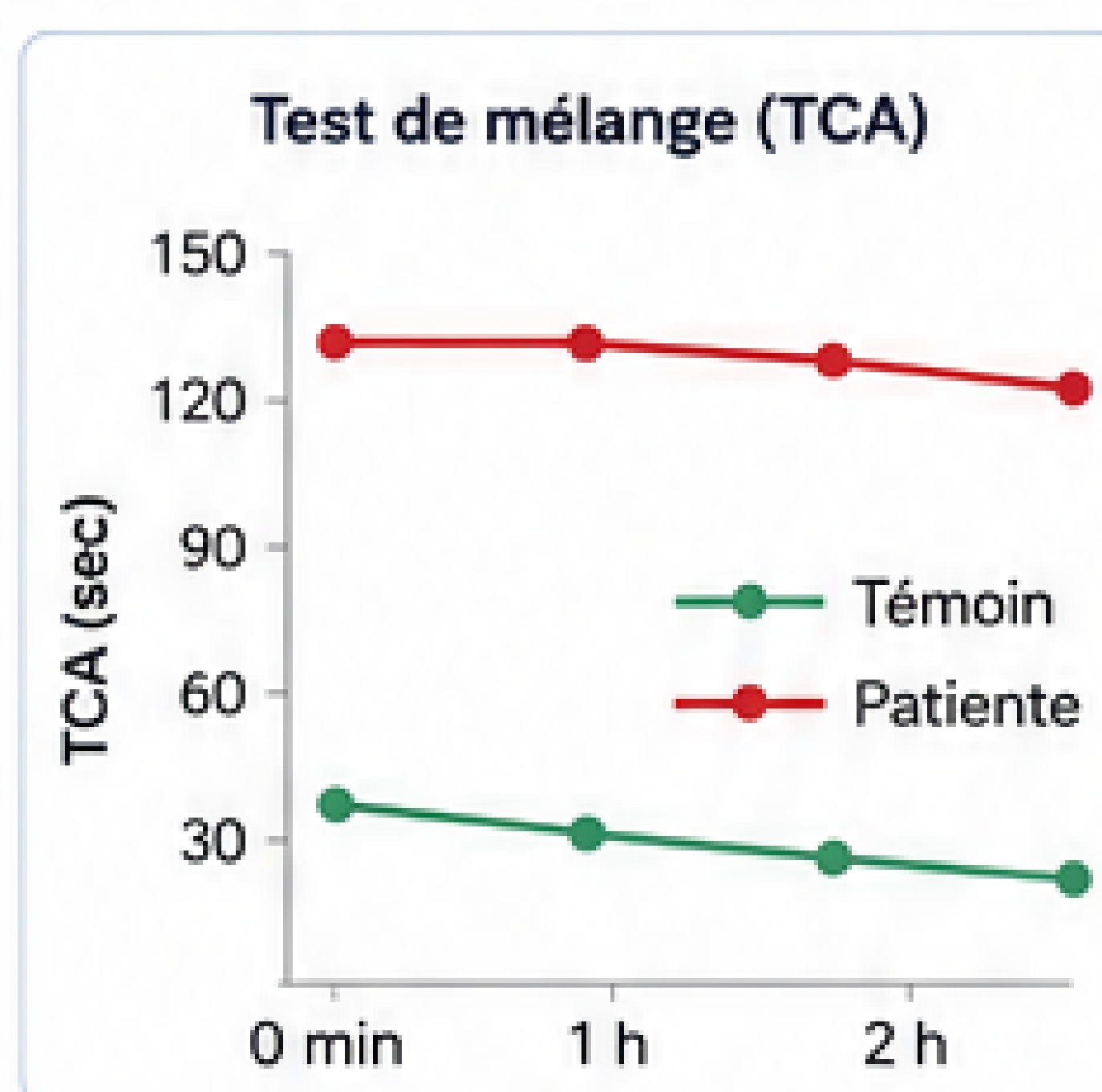
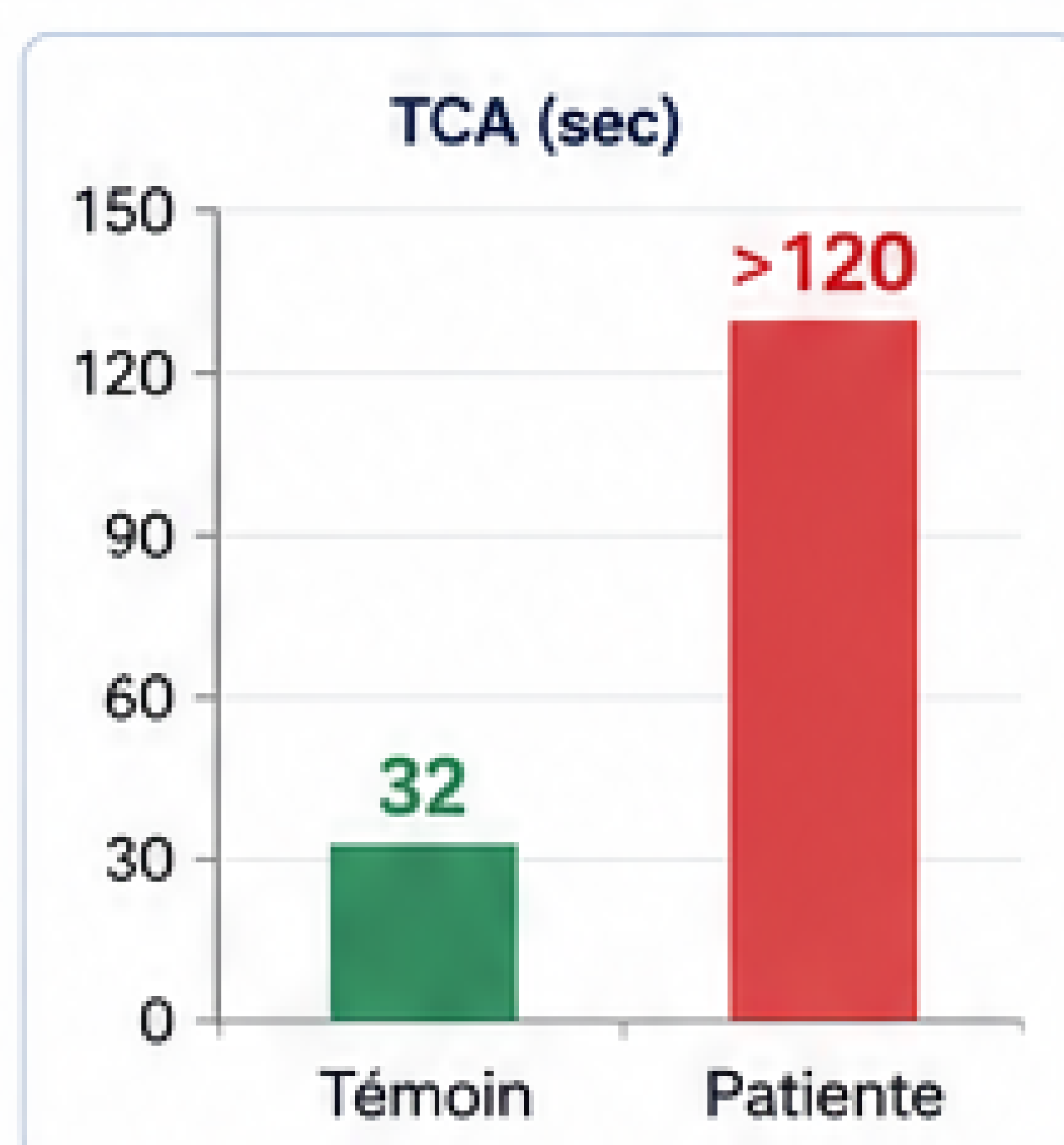
INTRODUCTION

L'hémophilie A acquise (HAA) est une maladie hémorragique rare due à la présence d'auto-anticorps dirigés contre le facteur VIII (FVIII). Elle survient le plus souvent chez l'adulte, sans antécédent hémorragique personnel ou familial, et peut être associée au post partum. Le diagnostic précoce et la prise en charge adaptée sont essentiels pour contrôler les saignements et traiter l'inhibiteur.



RÉSULTATS BIOLOGIQUES

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
TP (INR)	1,05	0,8 – 1,2
TCA (sec)	> 120	25 – 35
Fibrinogène (g/L)	3,2	2 – 4
Plaquettes (G/L)	100	150 – 400
Facteur VIII (%)	8	50 – 150
Test de correction (mélange)	Non corrigé	—
Indice de Rosner	54	> 15 : Inhibiteur présent
Anticorps anti-phospholipides	Négatif	Négatif



Le test de mélange ne se corrige pas dans le temps, suggérant la présence d'un inhibiteur.



PHYSIOPATHOLOGIE



CONCLUSION

L'hémophilie A acquise doit être évoquée devant tout allongement isolé du TCA chez une femme en post partum présentant des saignements inexpliqués. Une prise en charge rapide et adaptée permet de contrôler les saignements et d'obtenir une rémission.



MOTS-CLÉS

Hémophilie A acquise • Post partum • Hémorragie • Facteur VIII • Inhibiteur



CAS CLINIQUE



28 ans, primipare, avec un kyste ovarien.
Aucun antécédent hémorragique personnel ou familial.



JOUR 1

Post partum : apparition d'hématomes et de saignements vaginaux abondants.



JOUR 5

Intervention chirurgicale :
enlèvement de garniture vaginale.
Hémorragie vaginale active observée.

EXPLORATION BIOLOGIQUE

TP et fibrinogène : normaux
TCA : allongé
Plaquettes : 100 G/L

ÉVOLUTION

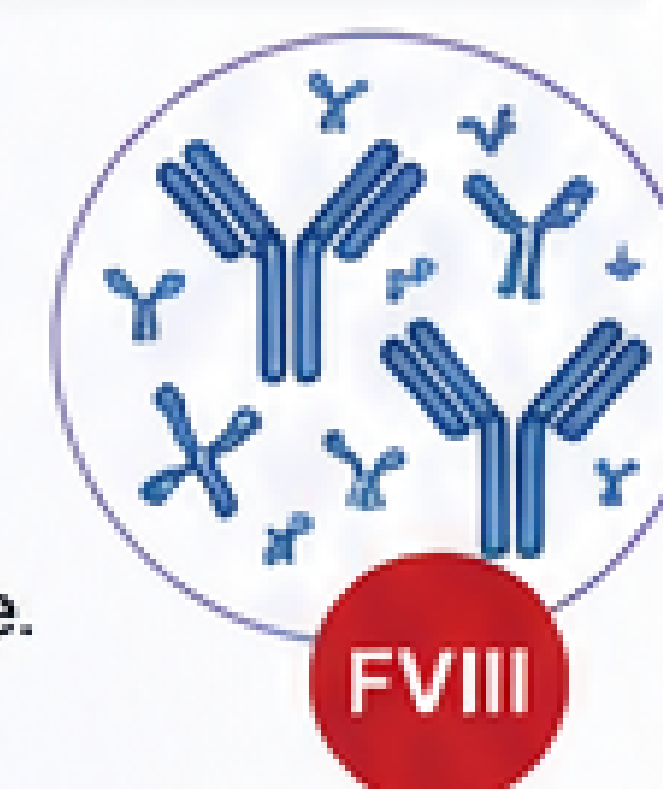
Le TCA reste allongé malgré transfusion de plasma frais congelé et de plaquettes.



DIAGNOSTIC

Le diagnostic d'hémophilie A acquise est retenu devant :

- ✓ Un allongement isolé du TCA non corrigé par mélange.
- ✓ Un taux de facteur VIII à 8 %.
- ✓ Une recherche des anticorps anti-phospholipides négative.
- ✓ Indice de Rosner > 15 (54) : présence d'un inhibiteur.



PRISE EN CHARGE

Traitement antihémorragique



Concentré de facteur VIII
administré jusqu'au contrôle
des saignements.

Traitement immunosuppresseur



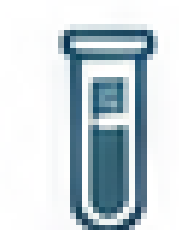
Corticothérapie à forte dose
(Prednisone seule).



ÉVOLUTION



Saignements vaginaux
contrôlés.



Taux d'hémoglobine
stabilisé.



Patient mise sortante
en bon état.



DISCUSSION

- L'HAA post partum est exceptionnelle, mais gravissime en raison du risque hémorragique.
- Le diagnostic repose sur l'allongement isolé du TCA, non corrigé par mélange, et la mise en évidence d'un inhibiteur anti-FVIII.
- Le traitement associe un contrôle rapide des saignements et l'éradication de l'inhibiteur par immunosuppression.
- Le pronostic est généralement favorable si le diagnostic et la prise en charge sont précoces.



RÉFÉRENCES

- Collins P, et al. Acquired hemophilia A: pathogenesis, diagnosis, and treatment. Blood. 2007.
- Tiede A, et al. International recommendations on the diagnosis and treatment of acquired hemophilia A. Haematologica. 2020.
- Franchini M, et al. Acquired hemophilia A: a concise review. Eur J Intern Med. 2013.